Resumos de Pediatria

Batistaz

Caderno de Estudos · Emergência

Parada Cardiorrespiratória

Suporte básico e avançado de vida pediátrico

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Sumário

Parada cardiorrespiratória pediátrica · suporte básico e avançado

I É parada, parada respiratória ou bradicardia? 3
Reconhecer, pulso em 10 s, quando comprimir com pulso

II Como fazer compressões de qualidade? 4
Frequência, profundidade, técnica e relação compressão:ventilação

III Ventilação, oxigênio, via aérea e acesso 5
Bolsa-máscara, via aérea avançada, intraóssea

IV O ritmo é chocável? 6
Assistolia e AESP × FV e TV sem pulso

V Ritmo não chocável 7

VI Ritmo chocável 8
Energia, adrenalina, amiodarona

VII Causas reversíveis e drogas seletivas 9
Hipóxia, hipovolemia, glicose, cálcio, bicarbonato, magnésio

VIII Bradicardia com pulso 10
Oxigenar, comprimir se < 60, adrenalina, atropina

IX Taquicardia com pulso 11

X Depois do retorno da circulação 12

XI Mapa de decisão e pegadinhas 13

XII Questões de estudo 14

— Gabarito, fontes e anotações 15

Como ler este caderno

Cai na prova — O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta — O que fazer no plantão, em ordem.

Atenção — Armadilha clínica ou divergência entre diretrizes.

Fontes: [SBC] diretriz brasileira 2019, [ERC] europeia 2025, [RCUK] britânica 2025, [AHA] SBV pediátrico 2025 (trechos). Onde as fontes divergem, aparecem lado a lado.

Capítulo I

É parada, parada respiratória ou bradicardia?

Na criança, a parada costuma ser o fim de uma insuficiência respiratória ou circulatória que progrediu, e não um evento súbito como no adulto. Por isso ***assistolia e AESP*** *predominam, e reconhecer a deterioração cedo é a melhor prevenção* [SBC] [ERC].

Tabela 1 · *Três situações que se confundem*

Situação	Como reconhecer e o que fazer
PCR	Inconsciente, **sem pulso central** e em apneia ou **gasping**. Ritmos: assistolia, AESP, FV ou TV sem pulso. Iniciar RCP
Parada respiratória	Apneia ou respiração inadequada **com pulso**: abrir via aérea e ventilar, **12–20 ventilações/min**; reavaliar o pulso
Bradicardia com hipoperfusão	FC < 60 bpm com grave comprometimento cardiorrespiratório **apesar de oxigenação e ventilação efetivas**: comprimir, mesmo com pulso

[SBC] (diagnóstico de PCR, Tabela 12.1 de ventilação e fase 6 da bradicardia)

Pulso: no máximo 10 segundos

O profissional checa respiração e pulso **ao mesmo tempo**: **braquial no lactente**, **carotídeo na criança**, por no mínimo 5 e no máximo 10 segundos. Sem certeza de pulso, começa a compressão [SBC].

Cai na prova · gasping não é respiração

Criança inconsciente, sem pulso, com respiração agônica (gasping) está em PCR. O leigo não procura pulso: inconsciente e sem respiração normal já basta para começar [SBC].

Atenção · quem é criança para o algoritmo

SBC: lactente é < 1 ano (fora o recém-nascido na sala de parto); após sinais de puberdade, usar o algoritmo do adulto. **ERC:** lactente até 1 ano, criança de 1–12, adolescente de 13–18; o recém-nascido que já foi para casa segue o algoritmo pediátrico [SBC] [ERC].

Capítulo II

Como fazer compressões de qualidade?

*Verificar a segurança, checar responsividade, pedir ajuda (SAMU 192) e, reconhecida a parada, iniciar **C-A-B**: compressões, via aérea, ventilação* [SBC].

Tabela 2 · *Compressão torácica: SBC 2019 × ERC 2025*

	SBC 2019	ERC 2025
Início	C-A-B	**5 ventilações de resgate**, depois compressões
Frequência	**100–120/min**; retorno completo do tórax; superfície firme	
Profundidade	⅓ do diâmetro anteroposterior: **~4 cm lactente**, **~5 cm criança**	Pelo menos ⅓; adolescente 5–6 cm; nunca > 6 cm
Lactente	1 socorrista: **2 dedos** logo abaixo da linha intermamilar; 2 socorristas: polegares envolvendo o tórax	**Dois polegares envolvendo o tórax** em todas as situações
Criança	1 ou 2 mãos no terço inferior do esterno	1 ou 2 mãos na metade inferior do esterno
Relação	**30:2** (1 socorrista) · **15:2** (2 socorristas)	**15:2** se treinado em SBV pediátrico; senão 30:2
Pausas	< 10 s; trocar quem comprime a cada 2 min	Mínimas; < 5 s para o choque

[SBC] [ERC]. A SBC declara seguir as diretrizes AHA de 2015 no SBV pediátrico.

Cai na prova · AHA 2025 tirou os 2 dedos do lactente

No lactente, a AHA 2025 descreve só duas técnicas: **base de uma mão** ou **dois polegares envolvendo o tórax**. No registro que embasou a mudança, a técnica de 2 dedos não atingiu a meta de compressão em nenhum segmento. Criança de 1 a 8 anos: duas mãos comprimem mais fundo [AHA].

Cai na prova · 15:2 é com dois

Pela SBC, um socorrista sozinho faz **30:2**; dois profissionais, **15:2**. Com via aérea avançada, compressões contínuas e ventilação assíncrona [SBC].

Atenção · socorrista sozinho

Sem telefone, o ERC orienta fazer RCP por **1 minuto** antes de sair para buscar ajuda [ERC]. Ventilar é parte essencial da RCP pediátrica; se não for possível, comprimir e acrescentar ventilação assim que der [SBC].

Capítulo III

Ventilação, oxigênio, via aérea e acesso

Bolsa-válvula-máscara bem feita resolve a maioria; a via aérea avançada depende de indicação, equipamento e habilidade, e ***não pode atrasar*** *nem interromper a RCP [SBC] [ERC].*

- Ventilar com **O2 a 100%** durante a RCP; não titular a FiO2 na parada [ERC].
- Cada ventilação dura cerca de **1 segundo**, com expansão visível do tórax; evitar hiperventilar [SBC] [ERC].
- Bolsa-máscara a dois (um veda, outro aperta) quando difícil [ERC].

Tabela 3 · *Ventilação com via aérea avançada (compressões contínuas)*

Fonte	Frequência
SBC 2019	**1 a cada 6 s (10/min)**
ERC / RCUK 2025	Lactente **25** · 1–8 anos **20** · 8–12 anos **15** · > 12 anos **10** por minuto

[SBC] [ERC] [RCUK]. Se a ventilação contínua perder eficácia, o ERC admite voltar a 15:2.

Acesso vascular

IV ou intraóssea, sem parar a RCP. A intraóssea é preferível à via endotraqueal; se o acesso venoso provavelmente for difícil, ir direto à IO [SBC] [ERC].

Monitorização

- **Capnografia** contínua confirma a cânula, acompanha a qualidade da RCP e sugere retorno da circulação [SBC] [ERC].
- Com pressão arterial invasiva já instalada: diastólica ≥ **25 mmHg** no lactente e ≥ **30 mmHg** na criança [ERC].
- Glicose, potássio, hemoglobina, lactato e gasometria quando disponíveis; POCUS só com operador treinado e sem alongar pausas [ERC].

Atenção · intubação

O ERC limita a **2 tentativas** de 30–60 s cada, interrompendo se houver bradicardia ou dessaturação. Sem experiência, continuar com bolsa-máscara [ERC].

Capítulo IV

O ritmo é chocável?

A primeira decisão do suporte avançado é olhar o ritmo no monitor ou no DEA e separar dois caminhos [SBC] [ERC].

Não chocável

Assistolia e **AESP** (atividade elétrica sem pulso). O ERC agrupa aqui a **bradicardia com má perfusão**. Tratamento: RCP + adrenalina o mais cedo possível. Choque não tem lugar [ERC].

Chocável

FV e **TV sem pulso**. Tratamento: choque (desfibrilação, não sincronizada) e RCP imediata por 2 min. TV **com pulso** é outro algoritmo (capítulo IX) [SBC] [ERC].

DEA na criança

- Usar assim que chegar, seguir os comandos e voltar a comprimir logo após o choque [SBC].
- **Atenuador pediátrico** é preferível em menores de **8 anos** ou < **25 kg**, incluindo lactentes; sem pás pediátricas, usar o DEA adulto mesmo assim [SBC].
- ERC: modo pediátrico abaixo de 25 kg (cerca de 8 anos); com pás de adulto em criança pequena, posição **anteroposterior**, sem as pás se tocarem [ERC].

Tabela 4 · *Desfibrilação na FV/TV sem pulso*

Fonte	Energia
SBC 2019	Inicial **2–4 J/kg**; doses maiores, **até 10 J/kg**, parecem seguras e efetivas
ERC 2025	**4 J/kg** (teto de 120–200 J, conforme o aparelho); se mais de 5 choques (FV refratária), subir aos poucos até **8 J/kg**, máximo 360 J

[SBC] [ERC]. A sequência de energias da AHA 2025 não foi conferida nesta versão.

Cai na prova · não chocar assistolia

Assistolia "fina" ou linha reta não se desfibrila: RCP e adrenalina. E FV não se cardioverte em modo sincronizado [ERC] [SBC].

Capítulo V

Ritmo não chocável

Assistolia e AESP: ***RCP de qualidade, acesso IV/IO e adrenalina o mais cedo possível****, checando o ritmo a cada 2 minutos e procurando as causas reversíveis [ERC] [RCUK].*

Tabela 5 · *Adrenalina na PCR pediátrica*

Dose IV/IO	**0,01 mg/kg** = **0,1 mL/kg** da solução 1:10.000 (0,1 mg/mL)
Máximo	**1 mg** por dose
Repetir	SBC e RCUK: a cada **3–5 min** · ERC: a cada **4 min** (um ciclo sim, outro não)
Endotraqueal	Não é mais recomendada; se for a única via, a SBC usa **0,1 mg/kg** (0,1 mL/kg da 1:1.000)
Exemplo 10 kg	0,1 mg = **1 mL** da solução 0,1 mg/mL, seguido de flush

[SBC] [ERC] [RCUK]. RCUK escreve a dose como 10 mcg/kg, que é o mesmo 0,01 mg/kg.

Atenção · a dose do recém-nascido é outra

Na sala de parto a adrenalina IV é **0,02 mg/kg** (0,2 mL/kg da diluída) e a relação é 3:1. Não misture os algoritmos [SBP-NEO].

Conduta · a cada ciclo de 2 minutos

- Pausa curta para olhar o ritmo (e o pulso, se ritmo organizado).
- Trocar quem comprime.
- Adrenalina no intervalo da sua referência; anotar o horário.
- Revisar a lista de causas reversíveis (capítulo VII).
- Se surgir FV/TV sem pulso: ir para o algoritmo chocável.

Cai na prova · confundir concentração

A dose é em **mg/kg**; o volume depende da solução. Com 1:10.000 (0,1 mg/mL), **0,1 mL/kg**. A ampola de 1 mg/mL na veia, em volume de 0,1 mL/kg, daria dez vezes a dose [SBC].

Capítulo VI

Ritmo chocável

*FV ou TV sem pulso: **um choque**, retomar a RCP **imediatamente por 2 minutos** e só então reavaliar o ritmo. A pausa entre parar de comprimir, chocar e voltar deve ser mínima [ERC].*

Tabela 6 · *Sequência europeia (ERC/RCUK 2025)*

Momento	O que fazer
1º choque	4 J/kg; RCP 2 min
2º choque	4 J/kg; RCP 2 min
Após o 3º choque	Adrenalina **0,01 mg/kg** (máx. 1 mg) + amiodarona **5 mg/kg** (máx. **300 mg**) IV/IO; depois adrenalina a cada 3–5 min
Após o 5º choque	Nova amiodarona **5 mg/kg**, agora máx. **150 mg** (última); adrenalina segue no intervalo
FV refratária	Escalonar até 8 J/kg (máx. 360 J): ERC, se mais de 5 choques; RCUK, a partir do 5º

[ERC] [RCUK]. Lidocaína 1 mg/kg IV é alternativa se não houver amiodarona ou por decisão local.

Tabela 7 · *Antiarrítmicos na PCR pela SBC*

Amiodarona	**5 mg/kg em bolus**, máx. 300 mg por dose; pode repetir até 15 mg/kg/dia (2,2 g no adolescente)
Lidocaína	**1 mg/kg** em bolus IV/IO; manutenção 20–50 mcg/kg/min

[SBC]. O momento exato de introdução das drogas na sequência AHA 2025 não foi conferido nesta versão.

Cai na prova · amiodarona tem duas velocidades

Na **PCR**, 5 mg/kg em **bolus**. Na **taquicardia com pulso**, os mesmos 5 mg/kg em **30–60 min**, diluídos. Trocar uma pela outra é erro grave [SBC].

Capítulo VII

Causas reversíveis e drogas seletivas

*Procurar em paralelo à RCP: hipóxia, hipovolemia, distúrbios de potássio e outros metabólicos, hipotermia (abaixo de 30 °C: uma dose de adrenalina e no máximo 3 choques; 30–35 °C: adrenalina a cada ~8 min [ERC]); trombose, pneumotórax hipertensivo, tamponamento e tóxicos. O ERC organiza como **4 H e 4 T** [ERC].*

Tabela 8 · *O que tratar e com quanto*

Hipóxia	Conferir via aérea, vedação, expansão, equipamento; O2 100% [ERC]
Hipovolemia	ERC: cristaloide isotônico **10 mL/kg** por bolus, ou sangue na hemorragia. SBC (choque hipovolêmico): 20 mL/kg, repetir se preciso [ERC] [SBC]
Hipoglicemia	ERC: **0,2 g/kg** (SG 10% **2 mL/kg**), rechecar em 5–10 min. SBC: 0,5–1 g/kg (SG 10% 5–10 mL/kg). Só com hipoglicemia documentada [ERC] [SBC]
Torsades / hipomagnesemia	Sulfato de magnésio **25–50 mg/kg**, máx. 2 g: bolus na TV sem pulso com torsades; em 10–20 min se houver pulso [SBC]
Cálcio	Não é de rotina. SBC: hipocalcemia, hipercalemia, hipermagnesemia, intoxicação por bloqueador de cálcio; cloreto de cálcio 10% **20 mg/kg** IV/IO [SBC]
PCR por hipercalemia grave	**Diverge:** o ERC 2025 manda insulina 0,1 U/kg (máx. 10 U) + SG 10% 5 mL/kg e beta-2 IV, e **não** usar cálcio nem bicarbonato; a SBC 2019 ainda os lista [ERC] [SBC]
Bicarbonato	Não é de rotina. SBC: acidose metabólica grave com ventilação adequada, hipercalemia: **1 mEq/kg** em bolus lento [SBC]
Pneumotórax, tamponamento	Tratamento mecânico dirigido; POCUS pode ajudar sem parar a RCP [ERC]

Atenção · glicose diverge

A dose de glicose do ERC (0,2 g/kg) é bem menor que a da SBC (0,5–1 g/kg). Na prova, siga a referência da questão; no plantão, o protocolo do serviço [ERC] [SBC].

Cai na prova · nada de coquetel

Cálcio, bicarbonato, magnésio e glicose não entram "porque a parada está demorando"; só com o distúrbio identificado [SBC] [ERC].

Engasgo

Tosse eficaz: estimular a tosse, sem varredura às cegas. Tosse ineficaz e consciente: lactente, **5 golpes nas costas + 5 compressões torácicas**; criança, 5 golpes nas costas + 5 compressões abdominais. Se ficar inconsciente, iniciar SBV [RCUK]. A AHA 2025 segue a mesma ordem, **começando pelos golpes nas costas** também na criança; no lactente, as compressões torácicas passam a ser com a **base de uma mão**, e nunca compressão abdominal. Inconsciente: RCP já, sem checar pulso [AHA].

Capítulo VIII

Bradicardia com pulso

A pergunta é: ***a bradicardia está comprometendo a perfusão?*** *A* ***hipoxemia é a principal causa*** *das bradiarritmias na criança; oxigenar e ventilar vem antes de qualquer droga* [SBC].

Oxigenar	Abrir via aérea, oxigenar, ventilar; monitor e acesso.
FC < 60	FC < 60 com grave comprometimento apesar de oxigenação e ventilação efetivas: **compressões**.
Persiste	Persiste: **adrenalina** 0,01 mg/kg IV/IO, a cada 3–5 min; se persistente, infusão.
Vagal ou BAV	Tônus vagal aumentado ou BAV primário: **atropina**.
Refratária	Refratária por doença de condução: considerar marca-passo, com especialista.

[SBC]

Tabela 9 · *Drogas na bradicardia (SBC)*

Adrenalina	**0,01 mg/kg** (0,1 mL/kg da 1:10.000) IV/IO; endotraqueal 0,1 mg/kg; repetir a cada 3–5 min. Infusão 0,1–0,3 mcg/kg/min na bradicardia persistente
Atropina	**0,02 mg/kg** IV/IO por dose; limites: criança **0,1–0,5 mg**, adolescente **0,1–1 mg**. Pode repetir em 5 min, até 1 mg total na criança e 2 mg no adolescente

[SBC]

Atenção · peri-parada no RCUK

O RCUK usa, na bradicardia com pulso, adrenalina em bolus pequenos de **1–2 mcg/kg** ou infusão, e atropina **20 mcg/kg** (até 11 anos, máx. 0,5 mg). Não confunda com o bolus da PCR (10 mcg/kg) [RCUK].

Cai na prova · comprimir com pulso

Lactente com FC 50, pálido, mal perfundido, já ventilado com O2: **compressão torácica**. Pulso presente não impede [SBC].

Capítulo IX

Taquicardia com pulso

*Classificar antes de tratar: tem pulso? perfusão adequada? QRS estreito ou largo? É **sinusal compensatória** ou arritmia?* [SBC]

Tabela 10 · *Sinusal × TSV*

	Taquicardia sinusal	TSV
Causa	Hipóxia, hipovolemia, sepse, dor, febre, ansiedade, anemia	Arritmia; início abrupto
FC (pistas)	Varia com a causa	Lactente > 220; criança > 180
Tratamento	Tratar a causa	Vagal, adenosina, cardioversão

[RCUK]. *As frequências são pistas, não diagnóstico isolado.*

Tabela 11 · *TSV (e TV instável): doses*

Estável	Manobra vagal: gelo na face do lactente (sem obstruir a respiração); Valsalva na criança que colabora [SBC]
Adenosina · SBC	**0,1 mg/kg** (máx. 6 mg) IV em bolus rápido + flush de 3–5 mL; sem efeito, **0,2 mg/kg** (máx. 12 mg) [SBC]
Adenosina · ERC	0,1–0,2 mg/kg (máx. 6 mg); depois 0,3 mg/kg (máx. 12–18 mg) após pelo menos 1 min [ERC]
Instável	**Cardioversão sincronizada** imediata, com sedação e analgesia se possível, sem atrasar por acesso [SBC] [ERC]
Energia · SBC	TSV: **0,5–1 J/kg**; se persiste, **1–2 J/kg** [SBC]
Energia · ERC	1 J/kg, dobrando a cada tentativa até 4 J/kg [ERC]
Refratária · SBC	Amiodarona 5 mg/kg em 30–60 min (máx. 300 mg) ou procainamida 10–15 mg/kg em 30–60 min; não associar as duas [SBC]

Atenção · QRS largo

QRS largo de origem incerta: tratar como TV até prova em contrário. **TV com pulso e instabilidade** (hipoperfusão, hipotensão, insuficiência cardíaca): cardioversão sincronizada imediata, como na TSV instável [SBC]. A adenosina não reverte flutter, fibrilação, taquicardia atrial nem TV que não usam o nó AV [SBC].

Capítulo X

Depois do retorno da circulação

O retorno da circulação espontânea (RCE) não encerra a emergência: agora é evitar nova parada e lesão secundária, e tratar a causa. Reavaliar em ABCDE [ERC] [RCUK].

Tabela 12 · *Metas após o RCE*

	ERC / RCUK 2025	SBC 2019
Oxigenação	SpO2 **94–98%**; evitar hipóxia e hiperóxia	SpO2 **≥ 94%**, titulando o O2 para evitar hiperóxia
Ventilação	PaCO2 normal; volume corrente 6–8 mL/kg do peso ideal, PEEP 5	—
Pressão	PAS e PAM acima do **percentil 10**, por pelo menos 24 h	PAS acima do **percentil 5**, com fluidos e vasoativos
Temperatura	Controle de temperatura por ≥ **24 h**; evitar febre por ≥ **72 h**	Normotermia ou hipotermia em casos selecionados
Glicose	Monitorar; tratar hipoglicemia, evitar controle estrito que cause hipoglicemia	
Convulsões	Tratar as crises; não usar anticonvulsivante profilático de rotina [ERC]	

[ERC] [RCUK] [SBC]

Cai na prova · prognóstico não se dá cedo

Na criança com consciência deprimida ou sedada, adiar o prognóstico neurológico por pelo menos **72 h**, com avaliação multimodal; nenhum exame isolado (pupila, EEG, imagem, ETCO2, lactato) decide sozinho [ERC].

Conduta · destino e seguimento

- Consciência rebaixada após a PCR: **UTI pediátrica** [ERC].
- Investigar a causa; se suspeita de doença hereditária, avaliar a família [ERC] [SBC].
- Antes da alta: seguimento multiprofissional, reabilitação, apoio psicológico à criança e à família [ERC].

Capítulo XI

Mapa de decisão e pegadinhas

Reconhecer	Inconsciente, apneia ou gasping, sem pulso em até 10 s (ou FC < 60 com má perfusão apesar de ventilar): pedir ajuda, iniciar RCP.
RCP	100–120/min, ⅓ do tórax, retorno completo; 30:2 sozinho, 15:2 em dupla; O2 100%.
Ritmo	Monitor ou DEA. Assistolia/AESP: adrenalina já. FV/TV sem pulso: choque e RCP 2 min.
Drogas	Adrenalina 0,01 mg/kg (máx. 1 mg) a cada 3–5 min. Chocável refratário: amiodarona 5 mg/kg em bolus ou lidocaína 1 mg/kg.
Causas	4 H e 4 T; glicose, cálcio, bicarbonato e magnésio só com indicação.
RCE	SpO2 94–98%, CO2 normal, PA adequada para a idade, controle de temperatura, UTI.

Tabela 13 · *Pegadinhas de decisão*

Afirmação tentadora	Correção
Tem pulso, então não comprime	FC < 60 com má perfusão apesar de ventilar: comprimir
Gasping é respiração	Gasping sem pulso é PCR
Assistolia: desfibrilar	Não chocável: RCP + adrenalina
Adrenalina 0,1 mL/kg da ampola 1 mg/mL	0,1 mL/kg da 1:10.000 (0,1 mg/mL)
Intubar antes de qualquer coisa	Bolsa-máscara eficaz e compressões primeiro
Amiodarona com pulso em bolus	Com pulso: em 30–60 min
Cardioverter taquicardia sinusal	Tratar a causa (febre, dor, hipovolemia)
Manter O2 100% indefinidamente depois do RCE	Titular para SpO2 94–98% quando a medida for confiável
Prognóstico no dia seguinte	Esperar ≥ 72 h, avaliação multimodal

Capítulo XII

Questões de estudo

1. Lactente de 4 meses com bronquiolite grave, já ventilado com bolsa-máscara e O2 a 100%, mantém FC 50 bpm, pálido e com pulsos fracos. A conduta é:

A Aguardar, pois há pulso.
B Iniciar compressões torácicas.
C Desfibrilar.
D Dar bicarbonato.

2. Pela SBC, dois socorristas profissionais, sem via aérea avançada, fazem RCP numa criança de 5 anos na relação:

A 30:2.
B 15:2.
C 3:1.
D 5:1.

3. Criança de 20 kg em assistolia, com acesso IO. A conduta é:

A Choque de 40 J.
B Adrenalina 0,2 mg (2 mL da solução 0,1 mg/mL) e RCP.
C Adrenalina 2 mg.
D Atropina 0,4 mg.

4. Criança de 20 kg em FV. Pela SBC, a energia do primeiro choque fica entre:

A 10 e 20 J.
B 40 e 80 J.
C 200 e 360 J.
D Choque sincronizado de 10 J.

5. Lactente de 8 kg com TSV, perfusão preservada, sem resposta ao gelo na face. Pela SBC:

A Adenosina 0,8 mg IV em bolus rápido seguido de flush.
B Adenosina 6 mg IV lenta.
C Cardioversão de 4 J/kg.
D Amiodarona 40 mg em bolus.

6. Após o retorno da circulação, a meta de saturação pelo ERC/RCUK 2025 é:

A 100%, mantendo O2 máximo.
B 88–92%.
C 94–98%.
D Qualquer valor acima de 80%.

Gabarito comentado

1 · B. FC < 60 com comprometimento grave apesar de oxigenação e ventilação efetivas: comprimir, mesmo com pulso [SBC].

2 · B. 15:2 com dois socorristas; 30:2 com um. 3:1 é da sala de parto [SBC].

3 · B. Não chocável: RCP e adrenalina 0,01 mg/kg = 0,2 mg = 2 mL da 0,1 mg/mL [SBC].

4 · B. SBC: 2–4 J/kg × 20 kg = 40–80 J, não sincronizado. O ERC usa 4 J/kg (80 J) [SBC] [ERC].

5 · A. 0,1 mg/kg × 8 kg = 0,8 mg, bolus rápido com flush; a segunda dose seria 0,2 mg/kg [SBC].

6 · C. SpO2 94–98% após o RCE; a SBC fala em ≥ 94% evitando hiperóxia [ERC] [RCUK] [SBC].

Apêndice

Fontes e anotações

- [SBC] BERNOCHE, C. et al. Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019. *Arq Bras Cardiol*, v. 113, n. 3, p. 449-663, 2019. Capítulo pediátrico.
- [ERC] EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL. European Resuscitation Council Guidelines 2025: Paediatric Life Support. *Resuscitation*, v. 215, 110767, 2025.
- [AHA] AMERICAN HEART ASSOCIATION; AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Part 6: Pediatric Basic Life Support: 2025 Guidelines for CPR and ECC. *Circulation*, v. 152, supl. 2, p. S424-S447, 2025. Trechos arquivados.
- [RCUK] RESUSCITATION COUNCIL UK. *Paediatric algorithms and emergency drug chart*. Diretrizes 2025, revisão de fev. 2026.
- [SBP-NEO] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. *Reanimação do recém-nascido ≥ 34 semanas em sala de parto: Diretrizes 2026*.
- A diretriz AHA 2025 (Pediatric Basic and Advanced Life Support) não foi arquivada nesta versão.

Anotações